EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68832
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 09-08-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICTOR MANUEL CONTRERAS ARIAS			RUN	: 3.723.999-2
F.Nac	: 01-08-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 01-08-2023	Fecha Egreso	: 09-08-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ENCEFALOPATIA METABOLICA POR HIPERNATREMIA + UREMIA EN MEJORIA
2. AKI SOBRE ERC EST V RESUELTA
3. ACV ISQUEMICO OCCIPITAL, FRONTOPARIETAL Y TALAMICO DER. EMBOLICO VS HEMODINAMICO
4. OBS ESTENOSIS CRITICA/ OCLUSION ACI DER
5. T. DEGLUTORIO. GTT QX 26/7/23
6. FA PAROXISTICA CON RVR RESUELTA
7. NEUMONIA ASPIRATIVA POR E. COLI +SAMS EN TRATAMIENTO
8. ANTECEDENTES : HTA, HIPOTIROIDISMO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con hospitalización desde el 16/07/23 en Clínica Andes Chillán en relación desorientación, disartria y debilidad de HC izquierdo. Se estudia en dicho centro con RM protocolo stroKe en que se constata restricción DMI/ADC occipital, frontoparietal y talámico derecho. Se estudió con doppler de arterias cervicales en que se sospecha estenosis crítica/oclusión de ACI derecha. Ecocardiograma con FEVI mayor 55% sin trombos intracavitarios ni valvulopatías de relevancia. Holter de ritmo sin arritmias en ese momento. Durante hospitalización cursó con FA con RVR que se cardiovierte farmacológicamente.
En cuanto a la rehabilitación, se decidió a los 10 días de evento cerebrovascular, instalar GTT quirúrgica. Según traslado se mantiene sin cambios significativos. No se describen exámenes neurológicos en traslado, solo GCS 10-11 puntos.
Pte con Antecedente de ERC con creat basal peri 3.3-3.5. Previo a traslado con deterioro de función renal progresiva hasta 5.2 y uremia sobre 150. Elevación de Na+ con control de hoy en 164. Se calcula déficit de agua y en base a eso se incia corrección de hipernatremia y falla renal aguda mejorando función renal , actualmente en su basal 3.5, mejoría de Na 148 con mayor respuesta neurológica, mucho mas reactivo. Sin nuevas intercurrencias infecciosas
Se decide alta medica con HODOM para continuar terapia con kinesiologo y fonoaudiologo

PLAN DE MANEJO:

Control en Poli de neurología en 10 días Dr. Norambuena
Se mantiene solo con monoterapia de antiagregación. Según evaluación de funcionalidad se considerara inicio de anticoagulación
Seguimiento en domicilio por kinesiología y fonoaudiología
LAB CONTROL CON FUNCION RENAL Y ELECTROLITOS PREVIO A CONTROL EN POLI

INDICACIONES AL ALTA

1. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
2. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
3. HIDRALAZINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL
4. LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 100 MICROGRAMOS / DOSIS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. LACTULOSA SOLUCIÓN 65% FRASCO 200 MINILITROS 15cc cada 8 horas
7. CLORHEXIDINA 0,12 % FRASCO 120 MINILITROS aseo cavidad oral por 3 veces
8. CLORANFENICOL FRASCO 0,5 POR CIENTO / 10 MINILITROS APLICAR 2 GOTAS CADA 6HRS POR 7 DIAS
9. OMEPRAZOL COMP 20MGRS VO DIA POR 30 DIAS

OBSERVACIONES:

Pend rescatar cultivo de GTT

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO